



4

55. ÅRGANG | 04 • 2018

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Indhold

Hvornår bliver børns skærmbrug skadelig?

Et ungdomsliv i limbo

HELT PERFEKT?

**En invitation til udviklende prosesser – hvordan fagpersonen
kan innby folk til refleksive og samskapende prosesser**

Afmagtsprocesser i skolens fællesskaber

Komplekse interventioner i PPR – et pilotprojekt

Kompenserende it til ordblinde: en støtte eller en sovepude?

Fagideologiske og etiske udfordringer i den pædagogisk-psykologiske
tjenesten

En invitasjon til utviklende prosesser – hvordan fagpersonen kan innby folk til refleksive og samskapende prosesser



I denne artikkelen vil vi bidra med tanker om hvordan vi som fagpersoner kan legge bedre til rette for å gi større rom for den gode samtalen. At vi i samarbeid med folk bør bli mer opptatt av relasjonelle, dynamiske, samvirkende og samskapende dialoger (Anderson, 2013; Anderson & Gehart, 2007; Bateson, 1973). Kan det tenkes at psykiatrien er matet med en forståelse av folk som uavhengig av samfunnet de eksisterer i? Når lidelse kun forklares på individnivå, blir psykiatrien blind for samfunnet som en mulig kilde til lidelse. Vi tenker at psykiatrien har en for sterk tendens til å vektlegge en individfokuset tilnærming med utgangspunkt i de biologiske, kognitive og psykologiske forklaringsmodellene, og har et stort fokus på de tilnærminger som reduserer rommet for et svært viktig samfunns psykologiske perspektiv. Spørsmålet blir da blant annet hvordan vi skal bli i stand til å opparbeide et reflektert blikk på samfunnets diskurser, og se at vi som psykiatri har et viktig samfunnsansvar?

*Af Luuk L. Westerhof, klinisk spesialist i familierapi, sosionom,
og har en mastergrad i Health Promotion og
Svenn Erik Knutsen, cand.polit, klinisk pedagog og familierapeut*

Psykisk sykdom som begrep har de siste 25 årene fått stor plass både i media og fagfeltet. Diagnoser har blitt forklaringen på mange «sykdommer» koblet til tilsynelatende kausale «sannheter» (årsak-virkning-forklaringer) (Frances, 2013b; Gøtzsche, Smith, & Rennie, 2011; R. Whitaker, 2010; R. H. Whitaker & Borley, 2000). I tillegg har det i de siste årene blitt slik at visse diagnoser mer blir forstått som livsvarige tilstander og handikap (Hertz & Glomnes, 2011). Fra dette perspektivet er det ingen motsetning til selve konstruksjonene i diagnosesystemet, som er bygd opp rundt tanken om at vi har

en diagnose dersom vi fyller konkrete kriterier og at vi ikke har diagnosen når vi ikke lenger oppfyller disse (Hertz, 2013: 84).

Ut i fra dette perspektivet kan vi kalle diagnosesystemet for utvalgte øyeblikksbilder (Hertz & Glomnes, 2011). Med det understreker vi at diagnosens grunnleggende oppgave blir å bidra til at det oppstår andre mer konstruktive øyeblikksbilder, og det i kraft av det vi selv bidrar med (ibid). Alle øyeblikksbilder blir kontekstavhengig, og vi bør således betrakte menneskets utfordringer og levde liv innenfor det.

Vi må få mer kritisk refleksjon på hvordan fagprofesjonene i psykisk helsearbeid møter de som søker bistand. Vi tror det blir en alvorlig epistemologisk brist dersom vi ikke tillegger omgivelsene som folk blir en del av nok oppmerksomhet. I dag kan det oppleves som om dette ikke gis tilstrekkelig relevans. Etter mange år med utdannelser innen systemisk familierterapi og systemisk praksis i feltet vårt, synes fokuset på den biomedisinske modellen fortsatt å ha et godt fotfeste i behandlersystemet.

Møtet mellom folk og fagfolk innen psykisk helsearbeid bør bidra til å gi mer oppmerksomhet til å gjøre en forskjell som utgjør en forskjell, en tanke inspirert av Gregory Bateson (1972). Vi velger i artikkelen å benytte begrepet folk eller den andre, da vi mener at dette viser til det mer naturlige og mellommenneskelige, enn at vi benytter belastede begrep som bruker, klient eller pasient, begreper som lett fanger oss inni det som oppleves som vanskelig. Vi tror at begrepene (diagnostiske uttrykk) vi setter på hverandre stigmatiserer og blir kontekstskapende. Ord er ikke bare ord. Ordene vi benytter gjør noe med oss.

Vi vil sette fokus på hvordan vi som fagfolk kan bidra til mer ekspanderende¹ prosesser, og som i større grad invi-

terer folks egne meningsopplevelser til å bli mer nyttige. Hvordan kan folk i møtet med oss som fagfolk oppleve at de blir tatt på alvor, og på denne måten oppleve at det de sier blir hørt. Vi tenker for å få til dette, må de relasjonelle prosessene skape passe tilstrekkelige bevegelser i fellesskapene som folk og fagfolk sammen blir medskaper av. Systemet forandrer seg ikke, men folk i systemet forandrer seg og dermed systemet (Andersen & Seikkula, 2005; Bateson, 1972a; Seikkula, 2012; Seikkula & Arnkil, 2014).

Vi må representere en passe stor nok forskjell i dette møtet med den andre som vil gi en passe store nok bevegelse i kraft av mer inviterende, reflekterende, samvirkende og samskapende konversering mellom oss som fagfolk og folk som søker vår bistand. Hvor vi gjennom genuin refleksiv lytting og ved å innta en ikke – vite posisjon, vil vi kunne bidra til å lokke frem det som ennå ikke er uttrykt. Ikke – vite posisjonen kommuniserer at vi som fagfolk ikke fremstår som Eksperten, men mer å sette fokus og nysgjerrigheten på den andre. Slik setter vi folks ideer og tanker foran våre egne (Nichols, 2013). Vi må derfor bli mer nysgjerrig på den andres hverdagsspråk, noe Anderson & Gehart omtaler som lokalspråket (2007). Poenget blir at vi sammen med den andre må mobilisere ressursene i stedet for å være for opptatt av å fremstille oss som Eksperten som kan og vet alt.

Ekspanderende passer bedre med henhold til nysgjerrig, ikke-deterministisk tenkning.

1 I artikkelen brukes bevisst begrepet – ekspanderende- fremfor begrepet utviklingsfremmende. Anderson i (Anderson & Gehart, 2007, p. 14) viser til at utviklingsfremming som begrep, kan assosieres med en forutsetning om, en slags «progresjon» hvor det nyeste alltid vil bli foretrukket.

Paradigmer, epistemologi og terapeutisk posisjon

Begrep som paradigme og terapeutisk posisjon henviser oss til begrep som modernisme og postmodernisme. Begge viser til filosofiske tradisjoner og med fokus på begivenheter som står i sterk kontrast til hverandre. Begge forholder seg til forståelse av virkeligheten på ulik måte. Modernismen viser til en ytre objektiv og sann virkelighet, et fokus på individet og dets intrapsyriske verden, på å tenke lineært og at språket vårt avbilder denne virkeligheten. Våre handlinger knyttes til denne intrapsyriske verden. All kunnskap er objektiv og vi tenker gitte sannheter som universelle. Virkeligheten blir fakta, og den er uavhengig av observatøren. Som terapeuter inntar vi en instrumentell posisjon, oss og de andre, og hvor terapeutens intensjon ensidig blir å utforske den andres intrapsyriske verden, for så forandre den andre med sin Ekspert viten og tiltak. Terapeuten blir den som ut fra sine teorier vet hvordan ting bør være (Anderson, 2003). På dette vis inntas *forfatterposisjonen*. Vi forteller den andres historie. En slik tilnærming vil undertrykke den andres kunnskap, og inviterer lite til gode prosesser!

Postmodernismen som motpol blir en kritikk av en slik tenkemåte. Den viser til mer fokus på det som samskapes i rommet mellom, på det sirkulære, det interaktive, samvirkende og relasjonelle, til det subjektive og til alle stemmenes likeverdighet. All kunnskap blir sosialt konstruert og vi tenker et mangfold eller multivers. Det er den andre som blir Ekspert på seg selv. Te-

rapeutens posisjon blir relasjonell og en invitasjon som samarbeidspartner, som sammen med den andre samskaper eller konstruerer virkeligheten. Vi blir *medforfattere* til historien. På dette vis løfter vi frem den andres kunnskap.

Når vi jobber sammen med folk, blir det derfor viktig å definere fra hvilken posisjon eller paradigme vi velger å tilhøre eller trives i. Posisjonen setter premiss for hva vi velger å vite i forhold til det vi observerer. Ønskes en endring kreves som regel et skift i posisjon for å unngå «mer av dets samme». Biologen Humberto Maturana (Maturana & Varela, 1980; Varela & Maturana, 1998) uttrykte, at enhver observasjon gjøres av en observatør, og observasjonen sitter i øyet til den som observerer. Begrepene epistemologi² og paradigme³ eller forståelsesmodeller blir derfor viktig for hvilken terapeutisk posisjon vi vil finne oss til rette i, og som vi inviterer folk til.

Medisinen som det psykiske helsearbeidet i stor grad tuftes på, representerer et vitenskapssyn forankret i modernismen, i det tradisjonelle og biomedisinske paradigmet. Det biomedisinske paradigmet med sin objektivitet og universelle sannheter som vitenskapen

2 Epistemologi er gresk og er et vanlig navn for erkjennelsesteori. Navnet er konstruert ut av de to greske ordene epistēmē og logos, som gjerne oversettes med henholdsvis kunnskap, innsikt og erkjennelse, samt teorien om, forklaringen av eller læren om. Epistemologi er læren om kunnskap og innsikt: hvordan vet vi det vi vet?

3 Begrepet paradigme brukes om kunnskap og resultater som i vitenskapen anerkjennes for gitt.

kan teste med standardiserte metoder (Mjaaland, 2017: 51). Behandling blir her rettet mot individet. Det blir lite fokus på de kontekstuelle og økologiske faktorene. Diagnoser og eventuelle tiltak blir således individbasert (Vedeler 2016). Disse fastsettes av Eksperten. Det postmoderne paradigmet fokuserer det biopsykososiale, kontekstuelle og økologiske helhetsperspektiver, uansett forhistorie (Vedeler, 2016:3).

Psykologspesialist Gerdt Henrik Vedeler spør om den medisinske modellen passer i psykisk helsevesen? Han mener selv nei! Kjernen i medisinen er å avdekke objektive fakta, mens psykososiale problemer er mer subjektive, unike, mangetydige og flytende (Mjaaland, 2017: 268; Vedeler, 2016). Vi bør kanskje heller undre på om psykisk helsevesen passer inn i den medisinske modellen, eller om den bør befri seg fra denne? Vi mener at problemer i stor grad blir utfordringer som oppstår i språket og samtalen vi bruker i samhandling med hverandre. Det er ikke problemet som er problemet, men måten vi snakker om problemet på (Anderson, 1997; Anderson & Gehart, 2007; Anderson & Goolishian, 1995; Anderson & Jensen, 2007, 2008). Dette står i kontrast til en definerende, dehuman og diagnostisk psykiatri. «Vi må få vekk sjukdomsspråket fra psykisk helsevern og halde oss til dei spesifikke problema som folk har» sier psykiater Trond Aarre (2017). Vi ser at disse polariseringene mellom to ulike paradigmer inviterer folk til ulike terapeutiske verdener og vilkår.

Reflekterende samtaler – å være sammen så det hjelper

Når folk over tid opplever å havne i vanskelige livssituasjoner, blir det av stor betydning om vi som fagfolk blir bevisst hvordan alvoret i folks livssituasjon inviterer oss til endrings og ekspanderende prosesser. Vi bruker bevisst begrepet å invitere da det er mange folk som sitter på et erfaringsgrunnlag med hjelpeapparatet som ikke udelt er positivt. Mange folk har derfor inntatt en mer reservert og taus posisjon, slik at de tar en minst mulig risiko på å få *mer av den samme* opplevelsen i møtet med oss. Å være reservert og taus kan således fungere som en nyttig beskyttelsesfaktor, og ikke en diagnostisk kategori. Den nye diagnosemanualen til DSM – V kan utgjøre en slik fare på ikke for uvanlige tilstander. Dette kan bety at vi som fagfolk i møte med folk må stille oss spørsmål om hvordan vi kan «lokke frem» lysten til at folk involverer seg i sin egen endringsprosess. For å lokke frem denne lysten må vi benytte en mer nysgjerrig og antropologisk tilnærming, slik at vi sammen kan få øye på de kreative mulighetene en dialog byr på. Vi må finne en måte å være sammen på som hjelper! Vi tenker også at det kan være fagfolks mangel på kreativitet som blir vår største hindring til å medskape en mer nyttig historie. Vi kan i vår iver etter å hjelpe bli så fagorientert at det mellommenneskelige drukner i «fine» ord og uttrykk.

Det kontekstuelle fokuset eller trykket blir særs viktig i en slik sammenheng. Vi kan ikke forstå folk isolert, men at konteksten blir det som gir farge til selve meningen når et menneske

og en fagperson reflektere sammen om de forskjellige utfordringer. Velger vi å se den andres utfordringer uten sin kontekstuelle sammenheng, kan det lett føre til forvirring og misforståelser. Dette er allmenn kunnskap, men allikevel holder vi ikke dette oppe i møte med den andre! Harold Goolishian (Anderson, 2003) uttrykte i sin tid en viktig setning som vi mener blir nyttig å reflektere; du må høre hva som blir sagt og ikke det du tror blir sagt! Fagfolks dominerende stemme vil fort overdøve og bringe den andre til taushet. Det blir fort slik at vi blir for raske i våre konklusjoner og forelsker oss i egne hypoteser. Sånn er det!

Terapeutens oppgave må bli å skape rom for reflekterende samtaler, hvor individet opplever seg hørt, sett og tatt på alvor, og slik invitere til attraktive samskapende dialoger hvor folk kommer i berøring med sitt utviklings – og mestringsrepertoar. Forestillinger eller identitet folk skaper om seg selv blir til gjennom språket som flettes sammen med verdiladede hendelser og egenskaper, og på den måten blir en historie om seg selv.

Å gjøre en forskjell

Folk oppsøker ofte våre hjelpetjenester når hverdagen går i lås og negative historier får en for dominerende plass og på den måten blokkerer for utfoldelse. I en tidligere artikkel (Westerhof & Knutsen, 2016) skriver vi om at dersom vi bidrar med for små forandringer eller bevegelser så risikerer de ikke å bli lagt merke til. For små forandringer risikerer således ikke å åpne opp for håp om mer virksomme prosesser, noe som vi mener må bli en forutset-

ning for å utvikle alternative og mer nyttige historier for det levde liv. Vi må mer våge å gi slipp på vår egen forståelse og bli mer nysgjerrig på den andres ideer og verden, og på den måten sammen bidra til å introdusere utforskede muligheter. Hvordan møtet med den andre (Wifstad, 1994) utspiller seg sammen med oss, blir vesentlig for hvordan den andre utvikler sitt liv. Vi blir en viktig kontekst for hverandre som enten hemmer eller fremmer.

Tom Andersen (I Anderson & Gehart 2007: 88) uttrykker at ulike meninger om et eller annet vil kunne skape problemer, og viser her til Harold Goolishian som lanserte begrepet det `problemskapte system`. Inspirert av Gregory Bateson (1972) mener Harold Goolishian at en problemsituasjon fort kan tiltrekke seg mange folk som utvikler en mening om hvordan dette skal forstås og takles. Om de har samme mening kan det fort bli repetisjoner, og lite nytt vil utvikle seg. Men, om disse menneskene har en passe forskjellighet i sin oppfatning i forhold til fenomenet vil de kunne ha nytte av hverandre og utvikle en ny og mer nyttig mening eller historie. Men om kontrasten dem imellom blir for stor, vil det ikke skje noe som oppleves som nyttig for den andre. En refleksjon rundt dette fenomenet må løftes mer frem i den terapeutiske hverdagen.

Individ, samfunn og diagnosen

Diagnoser er kunnskap, og som fagfolk må vi våge å spørre, hva slags kunnskap? Hvordan vi skiller mellom psykisk helse og sykdom, normalitet og

anomali, får konsekvenser for individet, hans eller hennes nettverk, økonomi, sosiale liv og samfunnet for øvrig. Tema om diagnoser har i de siste årene vekket forskjellige debatter i relasjon til diagnosens anvendbarhet og nytte. Psykiater og leder for arbeidsgruppa DSM- IV, Alan Frances tar sterk avstand fra store deler av diagnosemanualen DSM-V. Allen Frances (2013) skriver i sin bok «Saving Normal» at det har oppstått en diagnostisk inflasjon på grunn av den ukritiske anvendelse av diagnoser. og at den fremmer falske epidemier som ADHD, autisme, og bipolare lidelser hos barn (Frances, 2013). Han mener at diagnosesystemet har ført med seg en urovekkende ekspansjon i medikalisering.

Som fagfolk skal vi ikke underkjenne diagnosens plass i psykiatrien. Det er en forskjell mellom diagnoser relatert til intrapsyriske lidelser og til medfødte anomalier som benevnes som diagnose, f.eks. FAS føtal alkohol syndromet. Vi bør som fagfolk utvise en uhyre forsiktighet med å anvende diagnoser for raskt. Diagnoser bør være et alternativ, ikke et første valg (Frances, 2013b; Götzsche et al.; Hertz & Glomnes, 2011). Problemet med anvendelse av diagnoser er at fagfolk fokuserer på deler av konteksten. Dette ville ikke være så problematisk dersom fagfolk også satt delene tilbake i sine kontekster. Dette skjer i mange tilfeller ikke, og diagnosene settes dermed på et for tynt grunnlag da de mangler referanse til konteksten. Med det står fagfolk i fare for å sette en diagnose i relasjon til det som observeres av atferd, men ikke i relasjon til de forskjellige kontekster individet har blitt til innenfor,

interagerer med og er avhengig av. Mennesket er et meningssøkende vesen. Blir konteksten som en del av vedkommendes eksistens neglisjert, vil eksistensen i seg selv kunne oppleves som meningsløst i og med at det mangler kontekstuelle rammer som mennesket kan referere sin eksistens til.

Diagnoser blir identitetsskapende (Hertz & Glomnes, 2011) og etter vår kliniske erfaring er det mange folk som strever med å bli av med de forskjellige identiteter som de ufrivillig har blitt tilskrevet av en alt for løssluppen diagnosesetting. En diagnosesetting som så alt for lett settes på feilaktige tidspunkter i folks liv. For raske konklusjoner hindrer mer nyttig refleksjon og gir ikke invitasjon til gode utviklingsprosesser. En hovedregel for diagnosesetting bør være at det ikke skal settes noe alvorlig psykiatrisk diagnose om en vedvarende tilstand når et menneske befinner seg i et eksistensielt kaos. Vår erfaring er, at denne regelen ikke konsekvent blir overholdt. Dette medfører at mange strever med «feilaktig» identitet. Vansker som fremkaller symptomer i form av atferdsproblemer, konsentrasjonsvansker, rusmiddelmissbruk, kriminell atferd, avhengighetsproblematikk og lignende, eller annerledes sagt: normale responser på anormale utfordringer i barndom og oppvekst. Fremfor å bruke diagnoser som første valg argumenter vi for at fagfolk heller vektlegger utviklingen av dynamiske og skapende dialoger med folk hvor de begge kan få øyne på den støyen som har oppstått innenfor kontekstene av sosial uorden (Hertz & Glomnes, 2011). Det er disse kontekster av sosiale uorden som har bidratt til ut-

viklingen av problematferd. Og etter vår mening bør denne økologisk kontekstorienterte tilnærmingen (Arnesen, Ogden, & Sørli, 2006; Klefbeck & Ogden, 1995; Klefbeck, Ogden, & Haskå, 2003; Ogden, 2001) være et bedre alternativ i vår bestrebelse i å kunne forstå folk, fremfor for raske diagnoser. Det kan være nyttig å stille seg følgende spørsmål: «hvilken klinisk nytte opplever vi av dagens diagnoser i psykiatrien, og hva er alternativet?» En grunnleggende premisse for drøftingen blir at diagnoser ikke er allmenngyldige, og at de i det minste bør være til praktisk nytte for individet og fagfolk. Forsker og psykolog Peter Kinderman tar til orde for å slutte å diagnostisere psykiske lidelser, og i stedet diagnostisere selve problemene (Kinderman, 2014).

Og hva, om det er samfunnsdiskursene som i hovedsak skaper folks lidelse? Og verre, hva om disse diskursene i bunn og grunn reflekterer psykologiens egne diskurser? (Søreide, 2012). Vi lever alle i en verden som fylles med mer og mer digitalisering, og hvor det relasjonelle synes å tones ned i all effektiviseringen. Vi ser fastlegeordningen ofte som en buffer i møte med psykisk lidelse, men med for mange pasienter på listene og manglende kompetanse i alternativ tenkning. Reseptblokka blir en rask løsning!

Fagfolk får ofte ikke øye på endringspotensialer som vil komme til syne i dialogen mellom seg og den andre fordi han eller hun blir for fokusert på å individualisere problemet. Vi mener at å individualisere problemet kan føre til at dets opprinnelighet, men også dets endringsmuligheter blir til-

skrevet patologiske egenskaper. For mye oppmerksomhet rundt individfokuserte forklaringsmodeller vil etter vår mening fortrenge andre og mer retrukne historier.

Det er når diagnosen og sykerollen oppleves som attraktiv, at det blir nærliggende at vi utvikler en respekt for dette perspektiv (Hertz, 2013). Folk kan bli for fortrolig med sin diagnose eller sykerolle fordi det utløser ulike insentiver i hjelpeapparatet. Dette kan i seg selv oppleves som godt og behagelig, men folk står i stor fare for å bli tillært hjelpeløst (Seligman, 1972, 1978). Folks opplevelse av å ha betydning kan stå i fare for å viskes ut når diagnoser tar dets plass. Og vi må også huske på, at i tillegg til at diagnoser kan være nyttig og viktig, så bør diagnoser betraktes som øyeblikksbilder av væremåter og kommunikasjonsformer. De bør således betraktes som bidrag til kreative dialogiske prosesser (Hertz & Glomnes, 2011). Fra et slikt perspektiv bør fagfolk invitere til refleksive prosesser, som strekker seg forbi de negative dominerende forestillingene om angivelige etablerte sannheter. Tilsynelatende sannheter blir ofte til når livet er på vei til å låse seg.

Refleksive prosesser handler om «å lære å lære på nytt», noe som Bateson kaller for '*Deutero læring*' (Bateson, 1972). Vår oppgave som fagfolk blir ikke å forklare forskjellige fenomener, men å bistå folk til selv å få beskrive sitt liv. Tom Andersen uttrykte på et seminar i 2005 (PP – tjenesten i Kristiansand) at vi bør slutte med de frosne diagnosene og mer benytte oss av levende beskrivelser.. En fagperson som

ønsker å forstå menneskelig atferd må studerer levende systemer. Han må studere språk, relasjonsforhold, og de mønstre som binder sammen, «The patterns that connect», som Bateson uttrykker i *Steps to an Ecology of Mind*, (1972).

Her ligger det en utfordring for fagfolk. Han kan ikke lengre tenke at beskrivelser og forklaringer av fenomener skal bestemmes av fenomenet i seg selv, et slags «Ding an sich» (virkeligheten som den er i seg selv, uavhengig av vår erkjennelse av den) og dens egenskaper, slik at man ikke lengre er bundet av det underforståtte, av det som tas for gitt (Lock & Strong, 2014). På denne måten blir fagfolk frigjort fra oppgaven med å holde opp et speil som viser «verden slik den er» (ibid). Som fagfolk blir vi i stedet utfordret til å utvikle nye tanker og ideer.

En del fagfolk tenderer til å tro at folk blir *fastlåst* i bestemte atferds- og tankemønstre, og at det blir deres oppgave å finne metoder/teknikker til å løse opp denne fastlåstheden. Men folk som et levende og lærende system er ikke fastlåst i den forstand, at de ikke kan endres. Problemer blir heller ikke løst. Problemet er rundt et individ, og ikke nødvendigvis i et individ. Derfor handler det om sirkulære og reflekterende endringsprosesser der vi må samsnakke på en annen måte enn det som fremkalte det vanskelige. Som fagfolk kan vi ikke møte individet innenfor en kompleks verden med en lineær tilnærming og forklaringer. Enhver endring av et levende og lærende system ligger nedfelt i dets evne til å oppleve *mening* med eksistensen.

Hensikten med disse nye samskapte innsikter er, at folk ikke blir låst til én versjon av «virkelighet», men at han eller henne kan få øyne på mangfoldige versjoner av mulige virkeligheter. Det handler om evne til å bevege seg fra univers til multivers. Det er når vi ugyldiggjør eksistensen av flere parallelle alternative prosesser at folk kommer på kollisjonskurs med hverandre:

Når fagfolk blir forelsket i, og klammer seg til forutinntatte meninger, teorier, fordommer og konklusjoner, står han eller hun i fare for å miste mennesket i prosessen (Cecchin, Lane, & Ray, 2012). Ekspansjon i prosesser mellom fagfolk og individet oppstår, når vi i stedet for å snakke om folk som bærer av angivelige essensialistiske⁴ skavanker, må lærer oss å snakke om og fokusere på et mangfold av muligheter. Til enhver tid må vi være på vakt for at vi ikke blir lik den som trodde han visste alt, og det var akkurat det han visste. Som fagfolk må vi være interessert i hva det er det som gjør at vi tenker slik vi tenker. Denne tenkning om eget tenkende blir ofte vanskelig å forholde seg til for fagfolk, da dette utfordrer røttene til hans grunnlagstenkning som direkte berører hva han er styrt av.

Spørsmålet må ikke først og fremst være hva er galt med vedkommende,

4 Sykdom som oppfattes å ha selvstendig eksistens uavhengig av individet, og at enhver sykdom i prinsippet kan fjernes og behandles bort fra individet: Fra et essensialistisk sykdomsbegrep, leter man i prinsippet etter biologisk og psykologisk, objektiv kroppslig og psykisk sykdom og vurderer deretter hvor stor funksjonssvikt denne tilstanden med rimelighet kan forklare.

men heller hvordan skaper vedkommende mening i sitt liv? Derfor kan vi aldri snakke om folk som «avhengig» slik vi ofte gjør i forhold til folk som strever med rusmiddelmisbruk. Han er rusavhengig eller han er rusmisbruker. Avhengigheten ligger ikke nødvendigvis i individet, men i de kontekstene individet blir en del av, står i relasjon til, og interagerer med. Og det blir alltid slik at folk som en levende organisme responderer på de miljøene han eller hun ferdes i. Folk har ulike måter å være på i relasjon til de ulike kontekster han eller hun ferdes i. Disse ulike kontekstene står i relasjon til hverandre og informerer hverandre kontinuerlig. Derfor må vi forlate tenkningen om at noe er, men at alt kan bli. Denne tilnærmingen utfordrer den tiltagende individualisering som fagfellet dessverre i høy grad har blitt medskaper av, fordi vår organisering og våre konstruksjoner blir båret av den kultur vi er en del av (Hertz & Glomnes, 2011).

Kreativiteten mellom fagfolk og folk kan bidra til utviklingen av spennende og skapende prosesser hvor nye forståelser og muligheter kan komme til syne. Skapende kreative prosesser kan utvikles når vi blir tilstrekkelig nysgjerrig på sammenhenger og det fraværende implisitte, og ønsket om å skape bevegelse i det som tilsynelatende ser fastlåst ut (Hertz & Glomnes, 2011).

Den avdøde sosialpsykiateren Tom Andersen (Andersen, 2013) påpekte, at når vi har oppmerksomheten på en ting så blir noe annet skjøvet i bakgrunnen. Er fagfolk for opptatt med å forsvare sin for forståelse, da vil den andres uttrykk komme i bakgrunnen.

Endringsprosesser fordrer at fagfolk inntar en mer epistemologisk holdning. Vi må sette spørsmål ved våre egne tanker og begrunnelser om hvorfor vi tenker slik vi tenker. Det er når tanker og forestillinger om et fenomen blir gjort til allmenn gyldig sannhet, at fagfolks relasjon til individet står i fare for å låse seg. Av den grunn bør fagfolks relasjon til individet være med på å legge til rette for prosesser som rommer virkeligheter som vi deretter beskriver. Fagfolk må undre på hvordan folk egentlig klarer seg? Hvor ligger begrensningene og mulighetene for folk som et levende og lærende system?

Den andre, mangfoldet og sosiale kontekster

Når fagfolk jobber sammen med de som søker våre tjenester, blir det nyttig å se den andre med sitt mangfold av sosiale kontekster, noe som muliggjør at fagfolk kan få øye på folks varierte kontekstuelle identiteter. Et godt utgangspunkt er å se på folks atferd som del av variansen. Alt er kommunikasjon. Vi bør dog huske på at begrepet *normal* ikke har noe universal betydning og kan ikke bli definert med presisjon ved hjelp av filosofisk deduksjon, men det er i høy grad øyet som ser som bestemmer hva som ses, og at det som vi mener å se er foranderlig over tid, sted, og kulturer (Frances, 2013: 5). Psykiatriske diagnoser forutsetter som regel at individet er sykt, skadet eller har en lyte som utgjør en dysfunksjon og et avvik fra det normale. Etter vårt syn er det ikke sikkert at det er slik, men at diagnosesystemet har notoriske vansker med å skille klart mellom normalitet og avvik

(Francis, 2013). Det er etter vår forståelse bedre å forholde seg til folks plager som noe i utgangspunktet normalt, og en forståelig reaksjon på livet de lever og har levd, og ikke som uttrykk for at det feiler dem noe. Med det unngår vi at det som har oppstått i kontekster av sosial uorden, blir knyttet til biologiske essensialistiske skavanker eller en mangelforståelse (Hertz & Glomnes, 2011). Å se folk adskilt fra sin kontekst fører lett til at vi ser folk som et individ som ikke strekker til eller passer inn (Hertz, 2013: 84). Med disse tankene som bakteppe bør vi være opptatt av hvordan vi tar imot folks invitasjoner til et samvær som inviterer til endring og ekspansjon.

Det biopsykososiale postmoderne, sosialkonstruksjonistiske perspektiv

Til grunn for dette perspektiv ligger forskning fra de biologiske, psykologiske, og sosiale forskningsfeltene som forsterker og supplerer hverandre, spesielt i forhold til mulighetene for utvikling. Når det anlegges et biopsykososial perspektiv er det viktig å huske på at det biologiske ikke kan være statisk. Mye og nyere forskning er utviklingsorientert, og gjør at vi ikke kan snakke om absolutt viten, kun den viten, som vi spesielt velger og foretrekker.

Det dynamiske biopsykososiale perspektivet ligger nedfelt i forskning; en viten om hjernens plastisitet, og dens muligheter til utvikling i kraft av sosialt samspill i de for individet viktige relasjoner og kontekster (Hertz, 2013).

Relasjonell praksis i dialoger mellom folk og fagfolk handler om en bevisst-

het om, at fagfolk ikke har monopol på å vurdere og bedømme om et samarbeid har nytte og verdi for folk. Dette krever former for relasjonelt samvær enn det tradisjonelle moderne ekspert tilnærmingen. Det blir en annen type relasjon mellom fagfolk og folk enn der hvor rollene og de korresponderende handlinger betraktes som kulturelt eller profesjonelt forhåndsbestemt (Gergen, 1991, 1994, 2015; Gergen & Pro-Quest (Firm). 2001).

Fagfolk i relasjon med folk må ta høyde for at det biopsykososiale perspektivet bygger på hjerneforskning om speilnevroner, og som forteller oss at over tid er det ikke mulig i de betydningsfulle relasjoner (Hertz, 2008) å skille mellom egne og andres tanker, følelser og intensjoner (Horsdal, 2007). Dette betyr at speiling har en smitteeffekt. Dette er f.eks. viktig å huske på i et forebyggende perspektiv. Når vi speiler oss i andres tvil, bekymring, usikkerhet, så blir disse emosjonene veldig lett identitetsskapende, og denne smitteeffekten pendler frem og tilbake mellom folk og hans signifikante relasjoner.

Fra konklusjon til vurdering som en nødvendig forutsetning for ekspanderende og støttende prosesser

Kjernen innenfor reflekterende prosesser ligger i hvordan språklige vurderinger blir snakket om og fremtrer, og hvordan disse språklige vurderinger blir håndtert i et samarbeid mellom folk og oss som fagfolk. Dermed kan folk og fagfolk samarbeide og jobbe mot å utvikle betydningsfulle ressurser

som kan medvirke til at den andre når de målene han eller hun trenger å oppnå. Et slikt perspektiv betinger at fagfolk unnlater å konkludere, men heller lærer seg fortløpende å vurdere. Å dra konklusjoner setter en stopper for nysgjerrigheten som en forutsetning for produktive, genererende og ekspanderende prosesser. De som mottar denne kunnskapen hører altså et dobbelt budskap: Et budskap som beskriver tingene slik de ser ut til å være, og et budskap som forteller om hva som er ønskelig (Gergen, 1974, 2000).

Folk fødes forskjellig: Noen fødes med biologiske sårbarheter, andre utvikler en sårbarhet i regi av hva som skjer i deres liv. Oppgaven blir å være bevisst på *hvordan* man som fagperson møter den andre. Vi må møte folk på måter som åpner opp for utvikling, og som bidrar til biopsykososial modning (Hertz, 2013). På denne måten kan vi også få våre øyne på hvordan sårbarheter har blitt til og hvordan vi på best mulig måte kan håndtere de.

Hensikten og målet med ekspanderende endringsprosesser ligger ikke i en søken etter normalitet. Om fagfolk tenker slik vil de bidra med tanker om at alt forut ikke var normalt. Dette vil forstyrre folks nysgjerrighet på hvordan han eller hun kan være en bidragsyter til meningsfylte endringsprosesser. Barnepsykiater Søren Hertz (2013) skriver: «*Når medicin i nogle tilfælde virker, så hænger det sammen med, at barnet har været i samspil, som ikke har været tilstrækkeligt udviklingsfremmende og som har resulteret i, at barnet ikke producerer tilstrækkeligt af nødvendige transmitterstoffer*» (s. 85). Vi tenker at fagfolk bør bidra til,

at folk kommer i samspill hvor det kan oppstå produksjonen av tilstrekkelig transmitterstoffer, slik at vi eventuelt kan tenke en reduisering eller seponering av påbegynt medisinsk behandling som så lett kan utarte seg til å bli av livsvarig karakter.

Nyere forskning utfordrer tanken om at individet må lære seg å leve med ..., til fordel for et mer utviklingsorientert fokus. Fagfolks holdninger til individet preger kvaliteten på hvor nyttig de kan være. Dette aktualiserer også spørsmål som: *ser fagfolks individets behov eller kun sitt eget behov?* Klarer fagfolk å være en empatisk bistandsyter i møte med folk selv om han eller hun blir utfordret av dem? Den samskapende kraft av dialogen mellom fagfolk og folk avhenger av hans holdninger, og om han er i stand til å se den andres vansker.

Om fagfolk er pedagog bør han se disse vanskene fra et systemisk perspektiv, dvs. å se dette i sammenheng med de forskjellige miljømessige kontekster hvor vanskene kommer til syne (Klefbeck et al., 2003; Ogden, 1991, 2004). Som pedagog bør vi være bevisst på hvordan tanker om støtte introduseres, og hvordan denne bistanden kan fremskaffes. Oppmerksomheten rundt dette tema kan nemlig internaliseres som bevisste strategier, fordi omgivelser tror på at det er mulig, og de vil således støtte individet i å få seg erfaringer med hvordan det blir mulig å oppnå denne støtten. Dette er viktig å holde klart, fordi vi så lett kan miste grepet på ideen, om at støtte ikke bestandig er tilgjengelig utfra gitte forutsetninger. For det andre vil pre formulerte tanker om støtte begrense et fokus

på utviklingsmuligheter. Det som på forhånd er definert, kan lett legges til rette for «selvoppfyllende profetier» og i denne sammenhengen bli bærer av troen på begrensende muligheter, som smitter og pendler mellom individet og dens omgivelser (Hertz, 2013: 86). Fagfolk bør se etter muligheter i samarbeid med den andre og hvordan de kan komme vekk fra støttetanker og bevege seg mer mot utviklings og endringstanke (Hertz & Glomnes, 2011).

Vi må heller se hvordan vi kan få øye på de uante mulighetene. Dette er muligheter som ikke ligger i en dikotomisk enten eller tenkning, men i et både og perspektiv. Et perspektiv på muligheter krever en innstendig og uavlatelig nysgjerrighet som strekker seg forbi den begrensende dikotomiske «enten eller tenkning» og fokuserer heller på mangfold av muligheter. Dette åpner opp for utviklingen av doble beskrivelser som for eksempel: «Det jeg ser kan umiddelbart fremstå som ADHD, men jeg foretrekker å beskrive det sånn ...»? Disse beskrivelser tar mer utgangspunkt i brukerens levde liv, kontekster, av sammenhenger, av prosesser og av det som er på vei og som trenger ytterligere utvikling (ibid).

Invitasjon til det attraktiv samskapende samspill

All atferd blir kommunikasjon og all kommunikasjon kan betraktes som en invitasjon (Hertz & Glomnes, 2011). Dette perspektiv åpner opp for at også det man forbinder med problematferd bør møtes med nysgjerrighet, en nysgjerrighet som blir opptatt av hvordan fagfolk kan forstå folks atferd. Vi må ha i tankene at folks fremtoning til en-

hver tid er det han kan vise frem. Med det søker han også å forstå de innrissede historier og sosiale samspillsmønstre (Hertz & Glomnes, 2011). Som fagfolk bør vi være aktsom på hvordan vi svarer for denne form for kommunikasjon. Vi bør være nysgjerrig på de mulighetene denne form for kommunikasjon inviterer til, og hvilke muligheter for utvikling den byr på. Fra dette perspektiv kan vi betrakte denne kommunikasjonen som en innbydelse til et ønske om et annerledes og mer attraktivt sosialt samspill.

For å kunne forstå folks vansker som blir medbestemmende for dennes væremåte, bør vi anlegge et antropologisk perspektiv og en uavlatelig nysgjerrighet. På denne måten kan vi bedre forstå og forholde oss til det som fremstår som vanskelig. Individets kommunikasjon, hans invitasjoner må ses i lys av individets intensjoner om et annerledes samspill (Hertz & Glomnes, 2011).

Når diagnoser betraktes som dominerende væremåter, bør fagfolk se ved siden av diagnosen, slik at han kan få øye på det som ikke passer inn, det som lett kan overses dersom han ikke er nysgjerrig på hva som holder liv i de dominerende væremåter. Fra dette perspektiv er det betenkelig at det rettes så stort fokus på symptomene og hvordan de kommer til syne, når vi vet at disse væremåter kun blir bilder på folks mestrings og overlevelsesstrategier.

Det som fagfolk mer bør tenke på er at folks invitasjoner primært er rettet til de som er viktigst i hans eller hennes liv. Dette kan medføre en risiko. Dersom hjelpetjenesten foretar individuelle utredninger med fokus på problematferd, så vil den ikke få øye på de

skjulte invitasjonene, og med det stå i fare for å få kun et fokus på folks utilstrekkelighet og overlevelsestrategier. Med det får fagfolk ikke øye på de sammenhenger og kontekster som er så viktig for å kunne forstå den andres strev. Fagfolk må huske at kontekster ikke bare er noe han forholder seg til. Som folk er vi kontekstskapende og utleder mening fra disse. Folk utvikler seg i relasjonene mellom kontekster.

Med disse tankene bør vi som fagfolk spørre oss hvordan konteksten kan bli til og hvor vi kan få øye på dominerende forståelser og angivelige sannheter. På denne måten kan det i møte mellom fagfolk og folk oppstå noe som kan bli til inspirasjon, og som kan overføres til andre situasjoner og samspill. I psykiatrien, men også i rusomsorgen benytter vi oss ofte av forskjellige standardiserte spørreskjemaer, som i seg selv er kontekstskapende. Folk blir spurt om å fylle ut disse skjemaer som et ledd i en utredning, f.eks. Audit, Dudit, ASRS m.m. Spørsmålene på disse spørreskjema har et sterkt problemfokus, og med det er det allerede skapt en forestilling om hva undersøkelse går ut på. Vi bestrider ikke at disse testene kan ha sin funksjon, men vi ønsker kun å fremme tanke om at slike tester ikke må være første valg, men heller et eventuelt alternativ i tillegg til den gode samtalen. Går man rett på diagnostiske utredningstester kan det raskt skapes mentaltale kart hos folk om at det er noe galt med dem, fremfor tanken om at de lever i en for utfordrende livssituasjon!

Litteratur

- Aarre, T. (2017). Han vil slutte å gje diagnoser på psykiske lidinger. Publisert 12.08.2017, kl. 19:21 <https://www.nrk.no/sognogfjordane/trond-aarre-vil-slutte-med-diagnoser> (lest. 12.08.17).
- Aarre, T. (2017). Vil fjerne sykdomsspråket fra psykisk helsetjeneste. Publisert.21.08.2017. <https://sykepleien.no/2017/08/vil-fjerne-sykdomspraket-fra-psykisk-helsetjeneste>. Lest. 22.08.2017
- Andersen, T. *En av mange versjoner av reflekterende samtaler*.
- Andersen, T. (2013). *Reflekterende prosesser : samtaler og samtaler om samtalerne*. Kbh.: Nota.
- Andersen, T., & Seikkula, J. (2005). Åbne samtaler : – snak ikke om det usnakkelige. Århus: Videnscenter for socialpsykiatri.
- Anderson, H. (1997). *Conversation, language, and possibilities : a postmodern approach to therapy*. New York: Basic Books.
- Anderson, H. (2003). *Samtale, språk og terapi : et postmoderne perspektiv* (1. udgave. ed.). Kbh.: Hans Reitzel.
- Anderson, H. (2013). *Samtale, språk og terapi : et postmoderne perspektiv*. Kbh.: Nota.
- Anderson, H., & Gehart, D. (2007). *Collaborative therapy : relationships and conversations that make a difference*. New York: Routledge.
- Anderson, H., & Goolishian, H. A. (1995). *Från påverkan till medverkan : språk- och meningsskapande system i samverkan*. Stockholm: Mareld.
- Anderson, H., & Jensen, P. (2007). *Innovations in the reflecting process : the inspirations of Tom Andersen*. London: Karnac.
- Anderson, H., & Jensen, P. (2008). *Inspirasjon : Tom Andersen og reflekterende prosesser*. Oslo: Gyldendal.
- Arnesen, A., Ogden, T., & Sørli, M.-A. (2006). *Positiv atferd og støttende læringsmiljø*. Oslo: Universitetsforlaget.
- Bateson, G. (1972a). *Steps to an ecology of mind : collected essays in anthropology, psychiatry, evolution and epistemology*. San Francisco, Calif: Chandler.
- Bateson, G. (1972b). *Steps to an ecology of mind : collected essays in anthropology, psychology, evolution and epistemology*. London: Intertext Books.

- Bateson, G. (1973). *Steps to an ecology of mind : collected essays in anthropology, psychology, evolution and epistemology*. London. New York: Paladin.
- Bronfenbrenner, U., & ProQuest (Firm). (1996). *The ecology of human development : experiments by nature and design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Cecchin, G., Lane, G., & Ray, W. A. (2012). *Uærbødighed og fordomme* (1. udgave. ed.). Kbh.: Mindspace.
- Frances, A. (2013a). *Essentials of psychiatric diagnosis : responding to the challenge of DSM-5* (Revised edition. ed.).
- Frances, A. (2013b). *Saving normal : an insider's revolt against out-of-control psychiatric diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the medicalization of ordinary life* (1. ed.). New York, N.Y.: William Morrow.
- Frankl, V. E., Schjelderup, D., Retterstøl, N., & Jørgensen, J.-K. (2007). *Vilje til mening*. [Oslo]: Arneberg.
- Gergen, K. J. (1974). *Social psychology : Explorations in understanding*. Del Mar, Calif.: CRM Books.
- Gergen, K. J. (1991). *The saturated self : the dilemmas of identity in contemporary life*. New York: BasicBooks.
- Gergen, K. J. (1994). *Toward transformation in social knowledge* (2. ed.). London: Sage Publications.
- Gergen, K. J. (2000). *The saturated self : dilemmas of identity in contemporary life* ([New edition]. ed.). New York: Basic Books.
- Gergen, K. J. (2015). *An invitation to social construction* (3. udg. ed.). Los Angeles, Calif.: Sage.
- Gergen, K. J., & ProQuest (Firm). (2001). *Social construction in context*. London ; Thousand Oaks, Calif.: SAGE.
- Gøtzsche, P. C., Smith, R., & Rennie, D. *Deadly medicines and organised crime : how big pharma has corrupted healthcare*.
- Hertz, S. (2008). *Børne- og ungdomspsykiatri : nye perspektiver og uanede muligheder*. København: Akademisk forlag.
- Hertz, S., & Glomnes, J. J. (2011). *Barne- og ungdomspsykiatri : nye perspektiver og uante muligheter*. Oslo: Gyldendal akademisk.
- Horsdal, M (2007): *Livets fortællinger: en bok om livshistorier og identitet*, Borgen, København.
- Kinderman, P. (2014). *A prescription for psychiatry : why we need a whole new approach to mental health and wellbeing*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Klefbeck, J., & Ogden, T. (1995). *Nettverk og økologi : problemløsende arbeid med barn og unge*. Oslo: TANO.
- Klefbeck, J., Ogden, T., & Haskå, E. (2003). *Barn och nätverk : ekologiskt perspektiv på barns utveckling och nätverksterapeutiska metoder i behandlingsarbete med barn* (2., [omarb.] uppl. / ed.). Stockholm: Liber.
- Lock, & Strong, T. (2014). *Sosial konstruksjonisme : teorier og tradisjoner*. Bergen: Fagbokforlaget.
- Maturana, H. R., & Varela, F. J. (1980). *Auto-poiesis and cognition : the realization of the living*. Dordrecht: D. Reidel.
- Mjaaland, M. (2017). *Tvang og tvil – en innsideberetning fra norsk psykiatri*. from Kagge forlag
- Nichols, P. M. (2013). *Family Therapy Concepts and Methods*. Tenth edition. Boston.
- Ogden, T. *Et økologisk perspektiv på atferd i skolen*.
- Ogden, T. *Om multisystemisk terapi*.
- Ogden, T. (1991). *Specialpedagogik : att förstå och hjälpa beteendestörda elever*. Lund: Studentlitteratur.
- Ogden, T. (2001). *Sosial kompetanse og problematferd i skolen : kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen* (1. udgave, 1. opplag. ed.). Oslo: Gyldendal.
- Ogden, T. (2004). *Social kompetence og problemadferd i skolen : kompetenceudviklende og problemløsende arbejde i skolen* (1. udgave. ed.). Århus: Klim.
- Seikkula, J. (2012). *Åpne samtaler*. Oslo: Universitetsforlaget.
- Seikkula, J., & Arnkil, T. E. (2014). *Åben dialog i relationel praksis : respekt for anderledeshed i øjeblikket* (1. udgave. ed.). Kbh.: Akademisk Forlag.
- Seligman, M. E. (1972). Learned helplessness. *Annu Rev Med*, 23, 407-412. doi:10.1146/annurev.me.23.020172.002203
- Seligman, M. E. (1978). Learned helplessness as a model of depression. Comment and integration. *J Abnorm Psychol*, 87(1), 165-179.
- Søreide, L. (2012). Psykologiens samfunnsansvar. *Tidsskrift for Norsk psykologforening*, vol 49, nummer 1, 2012, side 96-100.
- Varela, F. J., & Maturana, H. R. (1998). *The tree of knowledge : the biological roots of human understanding*. Boston: Shambhala.

- Vedeler, G. H. (2016). Passer den medisinske modellen i psykisk helsevern?. Psykologisk.no <https://psykologisk.no/2016/03/passer-den-medisinske-modellen-i-psykisk-helsevern/> Lest.15.08.2017.
- Westerhof, L. L. & Knutsen, S. E. (2016). "Det passe Uvanlige" Spesialpedagogikk 2/2016.
- Whitaker, R. (2010). *Anatomy of an epidemic : magic bullets, psychiatric drugs, and the astonishing rise of mental illness in America*. New York: Crown Publishers.
- Whitaker, R. H., & Borley, N. R. (2000). *Instant anatomy* (2nd. ed.). Oxford: Blackwell.
- Wifstad, Å.(1994) Møtet med den andre. Om ekspertkunnskapens grenser i *Tidskrift for Den norske legeforening*, nr 30, 1094;114:3678-80 (3 s.)1. samling